

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN

NEUMOLOGÍA – ATENCIÓN PRIMARIA

V02 (Noviembre 2021)

**HOSPITAL REINA SOFIA -
DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR**

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la UGC de Neumología del Hospital Reina Sofía y las distintas UGCs del Distrito Córdoba y Guadalquivir, se ha establecido un grupo de trabajo con profesionales de los dos ámbitos asistenciales, que además de dar respuesta a las incidencias que se generan en la práctica diaria, garantice la mejora en la calidad asistencial en los pacientes.

Para ello, se establecen unos criterios de derivación por parte de Atención Primaria que permitan la actuación en acto único por parte de Atención Hospitalaria, y a su vez mejoren la comunicación y resolución de incidencias entre ambos niveles asistenciales, evitando que se generen consultas innecesarias y repetición de trámites administrativos ajenos a su práctica asistencial.

Para ello, se establecen los siguientes grupos de patología por motivos de consulta.

1.- SOSPECHA DE COVID PERSISTENTE

Son pacientes susceptibles de ser padecer COVID persistente aquellos que:

- Han presentado COVID moderado/grave y que **hayan precisado ingreso hospitalario en la planta de Neumología**
- Han presentado COVID leve manejado desde Atención Primaria y que desarrollan **síntomatología respiratoria**.

Por lo que estos pacientes podrán ser derivados a Medicina Interna mediante Teleconsulta cuando cumplan **Criterios de Inclusión:**

- Paciente con diagnóstico de COVID confirmado con pruebas de laboratorio.
- Los síntomas respiratorios han persistido en el tiempo más allá de 4 semanas desde el inicio del primer síntoma/síntomas atribuible a la infección aguda por SARS-CoV2.
- Los síntomas respiratorios formaron parte de la presentación clínica de la infección aguda por SARS-CoV2

Y no tengan **Criterios de Exclusión:**

- Los síntomas respiratorios ya existían antes de la infección aguda por SARS-CoV2.
- Los síntomas respiratorios no han formado parte de la presentación clínica de la infección aguda por SARS-CoV2.

Todos los pacientes derivados a Neumología mediante teleconsulta como COVID Persistente deberán:

- Definir de forma clara el **motivo de la derivación**, dónde se indiquen los signos o síntomas respiratorios de sospecha de COVID persistente.
- Indicar la **fecha del diagnóstico**, indicando la **prueba de PDIA** con la que se hizo el diagnóstico así como si preciso **ingreso hospitalario** (COVID moderado/grave) **o no** (COVID leve)
- **Tratamiento** indicado en la fase aguda (en COVID leve) así como los iniciados como sospecha de COVID Persistente.
- **Exploración física** centrada en el síntoma/síntomas de sospecha de COVID persistente, incluyendo en todos los casos auscultación cardiopulmonar, Frecuencia cardíaca, Tensión arterial y Saturación de Oxígeno.
- **Analítica con perfil de COVID PERSISTENTE** incluido en los perfiles de Atención Primaria.
- **Otras pruebas complementarias:** EKG, Radiografía de tórax en dos proyecciones y espirometría (solo será necesaria en los casos de Covid leve que presenten persistencia de sintomatología respiratoria)

2.- SOSPECHA DE APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (AOS)

La apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio más común relacionado con el sueño que hace que la respiración se detenga y comience repetidamente mientras se duerme.

Existen varios tipos de apnea del sueño, pero la más común es la apnea obstructiva del sueño. Este tipo de apnea ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan intermitentemente y bloquean las vías respiratorias durante el sueño. Un signo notable de apnea obstructiva del sueño es el ronquido.

Los signos y síntomas de la apnea obstructiva del sueño incluyen los siguientes:

- Somnolencia diurna excesiva
- Ronquidos fuertes
- Episodios observados de pausas en la respiración durante el sueño
- Despertar brusco con jadeo o atragantamiento
- Despertar con la boca seca o con dolor de garganta
- Dolor de cabeza por la mañana
- Dificultad para concentrarse durante el día
- Cambios del estado de ánimo, como depresión o irritabilidad

- Presión arterial alta
- Disminución de la libido

El aumento de las consultas relacionadas con trastornos del sueño en Atención Primaria hace necesario determinar que pacientes van beneficiarse de una ampliación del estudio por parte de Neumología así como la instauración de un tratamiento efectivo y corrector de la apnea.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Adultos con sospecha de apnea obstructiva del sueño (AOS) basado en síntomas: ronquido intenso y excesiva somnolencia diurna + 1 de los siguientes:

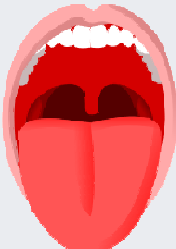
- **Apneas observadas**
- **Despertar asfíctico (con sensación de asfíxia)**
- **Sueño no reparador (con la sensación de no haber descansado)**

No son candidatos a derivar por Teleconsulta a patología del sueño:

- Insomnio
- Deprivación crónica de sueño
- Síndrome de piernas inquietas
- Hipersomnia no secundaria a SAOS (hipotiroidismo, depresión, enfermedad neurológica, ingesta de fármacos hipnóticos, etc.) o patologías respiratorias no relacionadas con SAOS.

Toda derivación por SAOS por Teleconsulta deberá contar con:

- **Anamnesis detallada**, dónde se refleje la presencia de síntomas relacionados con SAOS y tiempo de evolución, así como:
 - **Patología concomitante**, como HTA de difícil control, cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares o Fibrilación auricular de novo.
 - **Profesión de riesgo por somnolencia excesiva**, como conductor habitual en trayectos > 1 h, de vehículos públicos o maquinaria pesada (manejo de grúas, equipos de derribo, etc.) o trabajos en altura o verticales, actividades con riesgo de incendio, etc.
- **Exploración**, dónde se refleje obligatoriamente:
 - **Peso y talla (estimadas)**
 - **Grado de Mallanpati**, que nos orientará sobre la vía aérea. En el caso de que no podamos concretar el grado, podremos adjuntar a la derivación una fotografía de la boca abierta (sin respirar y sin emitir sonidos) mediante Capptura.

Clase	Características		
I	Total visibilidad de las <u>amígdalas</u> , <u>úvula</u> y <u>paladar blando</u> .	 	
II	Visibilidad del paladar duro y blando, porción superior de las amígdalas y úvula.		
III	Son visibles el <u>paladar duro</u> y blando y la base de la úvula.		
IV	Sólo es visible el paladar duro.		

- **Escala de somnolencia de Epworth**, disponible en Diraya a través del **Bóton Rojo (Herramientas de Farmacia)**

Esta escala valora las situaciones asociadas a la somnolencia.

- 1.- Sentado leyendo.
- 2.- Viendo la televisión.
- 3.- Sentado, inactivo, en un lugar público.
- 4.- Como pasajero en un coche durante una 1 hora seguida
- 5.- Descansando cuando las circunstancias lo permiten.
- 6.- Sentado charlando con alguien.
- 7.- Sentado tranquilamente después de una comida sin alcohol.
- 8.- En un coche, al pararse unos minutos en el tráfico.

pudiendo elegir **4 opciones en cada una de ellas**, con distinta puntuación

- 0 puntos: NUNCA se adormilaría.
- 1 punto: Pocas posibilidades de que se adormilase. LIGERA
- 2 puntos: Es posible que se adormilase. MODERADA
- 3 puntos: Grandes posibilidades de que se adormilase. ALTA

siendo el resultado que obtengamos

De 1 a 6 puntos: Sueño Normal

De 7 a 11 puntos: Ligera Somnolencia

De 12 a 24 puntos: Derivar para completar estudio

La no cumplimentación de los datos solicitados de anamnesis y exploración será motivo de rechazo de la Teleconsulta por falta de datos.

SITUACIONES ESPECIALES

Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que usuarios del SSPA hayan optado por una consulta en la medicina privada, dónde se le haya realizado las pruebas necesarias y se haya diagnosticado de SAOS, y que acudan al SSPA para el tratamiento, a estos pacientes se les realizará igualmente una Teleconsulta, dónde además de completar los datos de anamnesis y exploración, se enviará a través de Capptura toda la documentación que aporte el paciente para el diagnóstico de SAOS.

EN RESUMEN:

El objetivo de estos acuerdos es facilitar la consulta en acto único por parte del servicio de Neumología, mejorando su capacidad de resolución y accesibilidad a otros pacientes del SSPA.

Para ello, se establece que:

- 1.- Toda derivación a Neumología deberá realizarse con unos mínimos criterios de calidad en los que de forma inexcusable se informe del tiempo de evolución y el tratamiento empleado cuando proceda. La no inclusión de esta información en la derivación podrá ser motivo de devolución por falta de información.
- 2.- Toda sospecha de patología subsidiaria de ser valorada por Neumología o duda diagnóstica, será remitida para su valoración con los criterios antes mencionados. Tras la valoración, el servicio de Neumología emitirá en todos los casos un informe a través de Diraya, dónde de forma inequívoca conste si se procede al alta o si procede revisión, en cuyo caso, será gestionada directamente por el servicio.
- 3.- Para los pacientes que tras su valoración se indique un tratamiento o recomendaciones para el paciente, todas las prescripciones necesarias se realizarán a través de la aplicación de RXXI, y en caso de precisar revisión, con fecha de validez hasta la siguiente revisión.
- 4.- Los pacientes que ya han sido valorados por un motivo de consulta concreto con informe de alta por parte del servicio de Neumología y en dónde su médico de familia entienda que la evolución no es satisfactoria, se contactará con el neumólogo de referencia por medios telemáticos, y en caso de consensuar una nueva valoración, esta se generará como revisión a través de la UAC.
- 6.- Si tras una consulta con Neumología, el neumólogo determina que procede otra consulta con cualquier otro servicio hospitalario, esta se hará a través de Interconsulta Hospitalaria y no a través de Atención Primaria.
- 5.- El servicio de Neumología garantizará la comunicación telemática con los centros de atención primaria, nombrando referentes en cada uno de los centros y dando respuesta a las dudas y consultas solicitadas en el plazo establecido.
- 6.- El grupo de trabajo entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria mantendrá reuniones periódicas para valorar en cumplimiento de estos acuerdos.